

抗菌薬・抗ウイルス薬 抗真菌薬等の注射剤 初回施行時の手順

- 既往歴、特に薬剤アレルギーについては十分な問診を行う。
- 自分で訴える事ができる患者には「**抗菌薬の注射を受ける患者様へ**」の説明用紙を渡して薬剤の副反応について説明する。いつもとは違う具合の悪さを感じるがあったら、すぐにコールを押すよう説明する。
- ショック等に対する救急処置がとれる準備をしておく。
- 開始から終了まで安静状態に保たせ十分な観察を行う。
- 特に投与直後は注意深く観察する。
- アナフィラキシーは初回に限らず2回目3回目の投与でも起こりうるので、十分注意して施行する。

治療の必要性や危険性に関して、患者本人や家族に十分な説明を行い同意を得る。

- ①その薬剤の使用が初回である。
- ②前回の薬剤使用から2週間以上が経過している 場合は以下の手順で実施する。

薬剤アレルギーの既往がある場合

主治医報告し、使用について再確認。

使用が決定したら、**血圧・脈拍を測定し**、
患者の全身状態を観察する。

**生食50ml
Aセット・ベニユーラ針でルート確保し**、
溶解した薬剤を側管に接続する。

テストルート

薬剤を**20滴/分**の速度で、**5分間滴下**し、その間、
患者の状態を**ベッドサイド**で観察する。

テストルートが終了したら、**血圧・脈拍を測定し**、
「**抗菌薬・抗ウイルス薬・抗真菌薬等初回投与記録**」の
テンプレートに従って、全身状態を観察し、記録する。

変化がなければ、通常の滴下速度にして、点滴を続行する。
施行中はできるだけ安静にするよう患者に説明し適宜観察を行う。

終了後、再度状態観察を行い、患者の状態に変化がないことを
確認して記録を行う。

薬剤アレルギーの既往がない場合

血圧・脈拍を測定し、
患者の全身状態を観察する。

使用する薬剤を準備して
通常のセットで、患者に施注する。

変化があれば、直ちに滴下
を中止し、主治医に速やかに
報告する。

院内ルール

例えば、『ペニシリン禁』の申告が患者からあった場合、薬局にその内容を連絡する。薬剤師は、『ペニシリン系』の薬剤名をすべて、患者プロフィールに、アレルギー薬として登録する。

